Dolor crónico en el paciente pediátrico I

Dolor agudo y crónico en paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Dimensión del tema en el entorno

4. Clasificación del dolor crónico

Dolor nociceptivo
Dolor neuropático
Dolor psicógeno

5. La entrevista clínica en paciente infantil con dolor crónico

6. Evaluación del dolor crónico en el paciente pediátrico

Escalas verbales unidimensionales
Escalas verbales multidimensionales
Escalas conductuales

7. Bibliografía

Objetivos

- Detallar aspectos generales y epidemiológicos del dolor como manifestación clínica y del dolor crónico en el paciente pediátrico.
- Exponer las clasificaciones utilizada en el paciente pediátrico con dolor crónico, así como la importancia que tiene la entrevista médica en el diagnóstico y seguimiento al paciente pediátrico con DC.
- Describir los detalles que conforman la evolución del dolor crónico en el niño.

Introducción

El dolor es una experiencia extraordinariamente compleja, tanto que, a pesar de contar con procedimientos diagnósticos sensibles, complejos y de disponer de tratamientos médicos, farmacológicos y quirúrgicos muy sofisticados, muchos pacientes siguen sin obtener un alivio completo para los problemas de dolor.

Por definición, las mayores dificultades se encontrarán en el manejo del dolor crónico, un problema que se mantiene en el tiempo aun utilizándose los mejores tratamientos disponibles. A pesar de las reconocidas dificultades, en el tratamiento de las personas con dolor crónico se han producido progresos considerables a lo largo de los últimos 50 años (1) *(tabla 1).*

Comorbilidades asociadas al dolor
Depresión
Trastornos del sueño
Inmunosupresión
Falta de socialización
Ausentismo laboral
Discapacidad

Tabla 1.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial. El dolor es la principal causa de consulta, trayendo consigo una serie de comorbilidades que terminan afectando por completo la calidad de vida. Entre estas comorbilidades se incluyen depresión, trastornos del sueño, inmunosupresión y falta de socialización. El dolor crónico se convierte en una enfermedad per se, más que un síntoma. Además, es la principal causa de ausentismo laboral y discapacidad, lo que genera enormes costos secundarios (1).

El dolor agudo se define como dolor de reciente aparición y duración limitada, por lo regular tiene una relación temporal y causal identificable a una lesión o enfermedad, mientras que el dolor crónico (DC) se puede definir como comúnmente persistente más allá del tiempo de curación de una lesión y con frecuencia puede que no haya ninguna causa claramente identificable (1,2).

El dolor crónico, como ya se ha descrito, es un dolor que se extiende más allá de la lesión tisular o la afectación orgánica con la que, inicialmente, existió relación. También puede estar relacionado con la persistencia y repetición de episodios de dolor agudo, con la progresión de la o las enfermedades, con la aparición de complicaciones de las mismas y con cambios degenerativos en estructuras óseas y musculoesqueléticas. Ejemplos de lo dicho son el cáncer, fracturas patológicas secundarias, artrosis y artritis, neuralgia postherpética, entre otros.

El dolor crónico es percibido por quien lo sufre como inútil, pues no previene ni evita daño al organismo. Tanto la naturaleza como la intensidad presentan una gran variabilidad en el tiempo, en muchas ocasiones las quejas se perciben como desproporcionadas a las enfermedades subyacentes. Las repercusiones más frecuentes en la esfera psicológica implican ansiedad, ira, miedo, frustración o depresión que, a su vez, contribuyen a incrementar más la percepción dolorosa.

Figura 1

Las repercusiones socio-familiares, laborales y económicas son múltiples y generan cambios importantes en la vida de las personas que lo padecen y sus familias: invalidez y dependencia. La necesidad de uso de fármacos con que aliviar el dolor se convierte en un factor de riesgo potencial de uso, abuso y auto prescripción, no solo de analgésicos, sino también tranquilizantes, antidepresivos y otros fármacos (1,2) *(figura 2).*

Está demostrado que el enfoque multidimensional ha mejorado el resultado del abordaje terapéutico del dolor crónico en las últimas décadas. No obstante, en muchas ocasiones, el dolor crónico infantil es olvidado y cuesta trabajo reconocer que este enfoque es igualmente necesario en los pacientes pediátricos en los que el impacto del dolor sobre el desarrollo intelectual, físico y social del infante es muy marcado y compromete la evolución futura del paciente.

Por otro lado, no hay que olvidar el impacto negativo del dolor infantil en el entorno familiar directo del paciente, la presencia de dolor crónico en un miembro de la familia compromete el estado emocional, social y económico del resto, tanto padres como hermanos, por lo que todo el núcleo familiar debe ser tenido en cuenta como parte activa del problema y de la solución cuando un niño padece dolor crónico. Es muy importante conocer elementos que definen o las diferencias elementales del dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico de forma general (1,2) *(tabla 2).*

Dimensión del tema en el entorno *(Tabla 3)*

El dolor crónico infantil es una entidad clínica relativamente frecuente entre las consultas en los centros pediátricos, sin embargo, existen pocos estudios fiables que determinen la prevalencia de este problema en la población infantil, lo que supone un gran problema a la hora de establecer modelos asistenciales y coordinados que permitan su manejo. La presencia del dolor crónico afecta el ámbito familiar, social y psicológico de los infantes que están en fase de desarrollo físico, intelectual y emocional, lo que da lugar a un potencial deterioro de la persona en todas sus dimensiones y lleva al paciente a estados de ansiedad y depresión condicionado por el aislamiento social (3).

Figura 2.

Múltiples asociaciones implicadas en el manejo de patologías infantiles y abordaje del dolor denuncian, desde hace años, la falta de estudios que delimiten el problema sociosanitario del dolor crónico infantil. Se estima que hasta el 10 % en la edad preescolar y el 37 % de la población infantil entre 8 y 14 años sufre dolor crónico, de los cuales cerca del 5 % sufre un dolor severo que resulta incapacitante. Las afecciones más frecuentemente presentadas por la población pediátrica son las cefaleas (65,6 %), dolor abdominal (47,7 %), dolor de extremidades (46,4 %) y dolor de espalda (38,6 %).

El dolor está presente como síntoma asociado a múltiples enfermedades como el dolor oncológico, enfermedades reumáticas, parálisis cerebral o patologías neuromusculares. Son múltiples los retos que deben ser superados, incluso hoy en día, para un abordaje adecuado del dolor crónico infantil. Todos estos factores contribuyen a la invisibilidad de este problema sanitario a nivel social. Según múltiples asociaciones que combaten el dolor en el paciente pediátrico, el problema principal es que el dolor crónico infantil no existe para la sociedad, por lo cual no se evalúa ni se estudia y eso conlleva a que los pacientes pediátricos sean infra tratados o se traten parámetros validados en la población adulta (3).

Indudablemente existen retos en el manejo del dolor crónico en el paciente pediátrico. Entre estos retos se encuentran (3,4):

- Falta de formación específica en sanitarios.
- Falta de equipos multidisciplinares.
- Ausencia de unidades de dolor pediátricas.
- Falta de financiación de proyectos de investigación específicos sobre el dolor en el paciente pediátrico.
- Dificultad de comunicación con el paciente infantil.
- Dificultad del paciente pediátrico para autoevaluar el dolor.
- Miedo al empleo de fármacos coadyuvantes o del tercer escalón de la escala terapéutica de la OMS.
- Pobre experiencia en el manejo de técnicas invasivas en el control del dolor en el paciente pediátrico.
- Pobre empleo de terapias psicológicas, físicas y ocupacionales *(figura 3).*

El DC es un problema prevalente en la infancia, llegando a reportarse que hasta un 30 % de la población pediátrica tiene dolor a diario. Las quejas más frecuentes reportadas son dolor de cabeza (65,6 %), dolor abdominal (47,7 %), dolor de extremidades (46,4 %) y dolor de espalda (38,6 %). Además, en un 35 % el dolor se acusa durante un periodo mayor de 6 meses, lo que determina una prevalencia del dolor, ya como enfermedad en sí misma, mayor de lo que se podría esperar. Teniendo en cuenta todo lo descrito hasta ahora, es fácil deducir que el dolor infantil, en cualquiera de sus manifestaciones, está presente en un alto número de niños y niñas.

Diferencias entre dolor agudos y dolor crónico		
Diferencias	**Dolor agudo**	**Dolor crónico**
Finalidad	Inicial-biológica	Inicial-destructiva
Duración	Temporal	Persistente
Mecanismos generadores	Unifactorial	Multifactorial
Componente afectado	Orgánico +++ Psíquico +	Orgánico + Psíquico + ++
Respuesta orgánica	Adrenérgica: aumento de FC, FR, TA, sudoración y dilatación pupilar	Vegetativa: anorexia, estreñimiento, menor libido e insomnio
Componente afectivo	Ansiedad	Depresión
Agotamiento físico	No	Si
Objetivos del tratamiento	Curación	Alivio y adaptación

Tabla 2.

Dolor crónico: características
Entidad clínica frecuente en las consultas pediátricas.
No se conoce la prevalencia de esta enfermedad en niño actualmente.
El DC afecta al ámbito familiar, social y psicológico de los infantes que están en fase de desarrollo físico, intelectual y emocional.
El DC lleva al paciente a estados de ansiedad y depresión condicionado por el aislamiento social.
Se estima que hasta el 10 % en la edad preescolar y el 37 % de la población infantil entre 8 y 14 años sufre dolor crónico.
Las afecciones más frecuentemente presentadas por la población pediátrica son las cefaleas (65,6 %), dolor abdominal (47,7 %), dolor de extremidades (46,4 %) y dolor de espalda (38,6 %).
El DC está presente como síntoma a múltiples enfermedades como el dolor oncológico, enfermedades reumáticas, parálisis cerebral o patologías neuromusculares.

Tabla 3.

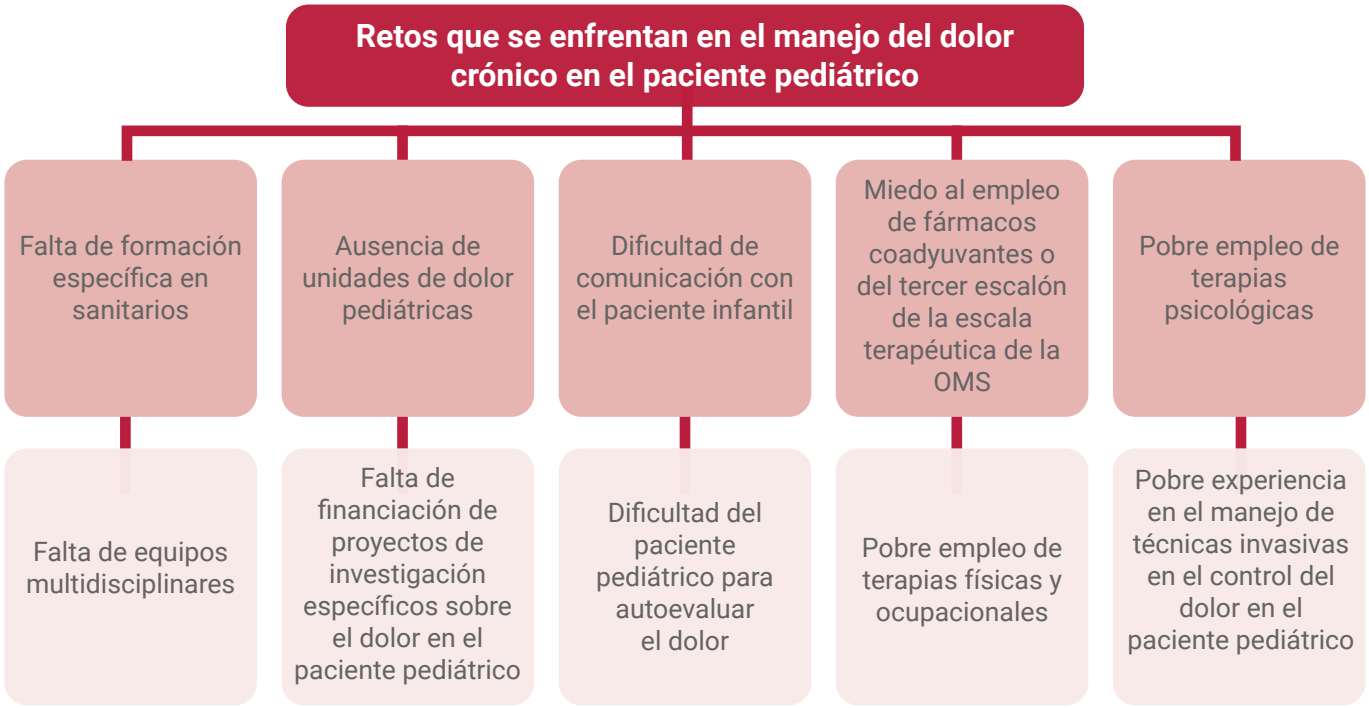

Figura 3.

La prevalencia real posiblemente sea muchísimo más elevada si se investigara la existencia de forma rutinaria en la asistencia pediátrica diaria (consulta, centro de salud, urgencias, entre otros). Es un hecho, por tanto, que el dolor infantil es prevalente y que este condiciona la calidad de vida de los pacientes y sus familias (3,4) *(tabla 4)*.

En resumen, la prevalencia del dolor en la población infantil resulta difícil de aproximar, no solo debido a las múltiples presentaciones posibles (agudo, crónico, nociceptivo, neuropático, entre otros), a las causas (enfermedades, procedimientos y cirugías) o al amplio rango de edades que diversifica la población de estudio (neonatos, lactantes, escolares y adolescentes), sino y más importante, a la todavía manifiesta minoría de estudios focalizados en el paciente pediátrico en la literatura.

Clasificación del dolor crónico *(Tabla 5)*

En el abordaje del dolor en el paciente pediátrico uno de los primeros aspectos es establecer una clasificación del mismo, lo que se realizará en función de los datos obtenidos de la evaluación clínica de la paciente, apoyada, en muchos casos, en la valoración subjetiva de los cuidadores, en mayor o menor medida, en el caso del paciente pediátrico en función de la edad.

En primer lugar, se establecerá la condición del dolor crónico en función de la duración del dolor y las características que lo diferencian del dolor agudo, como lo son los aspectos relacionados con el inicio o la evolución del mismo.

Dolor crónico: causas más frecuentes en edades pediátricas
Dolor de cabeza (65,6 %)
Dolor abdominal (47,7 %)
Dolor de extremidades (46,4 %)
Dolor de espalda (38,6 %)

Tabla 4.

Características del dolor crónico	
Inicio	Insidioso
Relación causa-efecto	+
Componentes	-
Duración	> 3 meses
Función fisiológica	Inútil
Respuesta conductual	Evitación/afrontamiento
Respuesta emocional	Depresión
Respuesta orgánica	Principalmente vegetativa

Tabla 5.

Es muy importante señalar que el dolor crónico de forma general se caracterizará por varios aspectos, entre los que se encuentran (1,2,5):

Clasificatoriamente el DC se podrá clasificar de diferentes formas. Se clasificará de acuerdo a la intensidad y finalmente, se utiliza la clasificación fisiopatológica. Esta es unas de las utilizadas. En función de la fisiopatología el dolor crónico puede ser nociceptivo, neuropático o psicógeno.

La IASP ha asesorado a la OMS mediante la creación de la Task Force for the Classification of Chronic Pain, compuesta por expertos mundiales en dolor crónico que han buscado una nueva clasificación pragmática y transversal con el fin de tener utilidad en medicina del dolor especializada, así como en atención primaria y con un enfoque taxonómico por prioridades, primero la etiología, seguido del mecanismo fisiopatológico y, por último, el área anatómica (5).

Se tienen de forma separada dos entidades, **el dolor crónico primario (caracterizado por alteración funcional o estrés emocional no explicable por otra causa) y se plantea como una enfermedad en sí misma y el dolor crónico secundario, que es una entidad donde el dolor es un síntoma de una condición clínica subyacente** (1).

La nueva clasificación divide el dolor crónico en siete grupos (6):

- **Dolor crónico primario:** se define como dolor en una o más regiones anatómicas que persiste o reaparece durante más de 3 meses, se asocia con angustia emocional significativa (por ejemplo, ansiedad, ira, frustración o estado de ánimo deprimido) o discapacidad funcional significativa y los síntomas no se explican mejor con otro diagnóstico.
- **Dolor crónico por cáncer:** causado por el propio cáncer primario, metástasis o el tratamiento (dolor crónico posterior al tratamiento del cáncer). Debe distinguirse del dolor causado por una enfermedad comórbida.
- **Dolor crónico postquirúrgico o postraumático:** se desarrolla o aumenta en intensidad después de un procedimiento quirúrgico o una lesión tisular y persiste más allá del proceso de curación, es decir, al menos 3 meses después de la cirugía o el trauma tisular.

- **Dolor crónico neuropático:** lesiones del sistema nervioso o enfermedades asociadas con el dolor persistente o recurrente durante más de 3 meses (neuralgia del trigémino, lesión del nervio periférico, polineuropatía dolorosa, neuralgia postherpética y radiculopatía dolorosa). Las condiciones de dolor neuropático central incluyen dolor causado por lesión de la médula espinal o cerebral, dolor posterior al accidente cerebrovascular y dolor asociado con la esclerosis múltiple.
- **Dolor orofacial y cefalea:** definido como dolor de cabeza u orofacial que ocurre al menos el 50 % de los días durante al menos 3 meses y que dura al menos 2 horas por día. Solo incluye la cefalea secundaria crónica y los trastornos orofaciales secundarios crónicos.
- **Dolor visceral crónico:** secundario a una afección subyacente que se origina en los órganos internos de la región de la cabeza, el cuello, torácica, abdominal o pélvica. Puede ser causada por inflamación persistente, por mecanismos vasculares o por factores mecánicos.
- **Dolor crónico musculoesquelético:** se define como el dolor crónico que surge de estructuras musculoesqueléticas como huesos o articulaciones *(figura 4).*

Como ya se había descrito, el DC en el paciente pediátrico, en función de la fisiopatología el dolor crónico puede ser nociceptivo, neuropático o psicógeno. ¿Qué características tienen estas formas de DC en el paciente pediátrico? Otro elemento que se quiere compartir es que el dolor crónico se puede clasificar en función de la evolución en el día *(figura 5)*.

La clasificación del dolor desde el punto de vista de la intensidad tiene sobre todo un valor práctico en el sentido de que orienta el enfoque terapéutico y permite valorar la respuesta al tratamiento analgésico en la práctica clínica. En la práctica clínica ninguna de las clasificaciones previas resulta suficiente por sí sola cuando se aplican de forma única, por lo que en la práctica habitual se emplean de forma conjunta, para obtener una información más detallada del dolor que permita abordar el problema de forma eficiente *(Figura 6).*

Dolor nociceptivo

Está causado por la activación los nociceptores A-δ y C en respuesta a un estímulo nocivo sobre los tejidos corporales, que puede ser secundario a una lesión, enfermedad, inflamación, infección o cirugía. En el dolor nociceptivo el funcionamiento del sistema nervioso es correcto. Es una respuesta fisiológica a una agresión. Una característica importante de este tipo de dolor es que en general, existe una importante correlación entre la percepción del dolor y la intensidad del estímulo desencadenante.

A su vez, el dolor nociceptivo se subdivide en dolor somático y visceral (6,7).

- **Somático:** proveniente de estructuras como piel, músculo, hueso articulaciones y partes blandas. Se trata de un dolor localizado, punzante o pulsátil.
- **Visceral:** se origina en mucosas y serosas de los órganos, músculos lisos y vasos. Es sordo, profundo, difuso, descrito como presión o tracción. La afectación visceral, puede añadir un componente de dolor cólico típico.

Dolor neuropático

Se origina como consecuencia de la afectación lesional o funcional del sistema nervioso, por tanto, supone la alteración del sistema nervioso, tanto central como periférico. El dolor neuropático se divide en (8,9):

- **Dolor neuropático central:** es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial central.
- **Dolor neuropático periférico:** es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial periférico *(tabla 6).*

Dolor psicógeno

No tiene una naturaleza orgánica sino características psicosomáticas, derivadas de una patología psiquiátrica más o menos importante. Se presenta en individuos con una personalidad alterada, ansiosos, depresivos, neuróticos, entre otros. Es un dolor que no obedece a ningún patrón neurológico definido y suele ser resistente a cualquier tipo de tratamiento, sea farmacológico o quirúrgico que no tenga en cuenta la naturaleza psiquiátrica (6).

La entrevista clínica en paciente infantil con dolor crónico

La entrevista clínica es una parte imprescindible y fundamental para el manejo del dolor, el cual es una experiencia subjetiva de modo que el estudio del mismo requiere de una valoración exhaustiva individualizada. Si bien la determinación del dolor crónico resulta difícil en cualquier paciente por las características difusas, el componente emocional impide a la persona explicar la sintomatología que padece y esta cuestión es especialmente compleja en el caso del paciente pediátrico en el que la inmadurez o la falta de capacidad de comunicación los hace incapaces de explicar la situación.

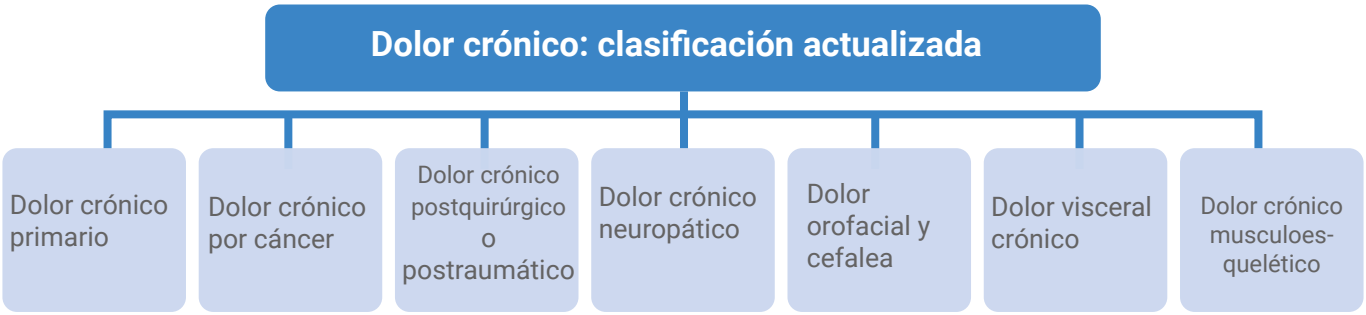

Figura 4.

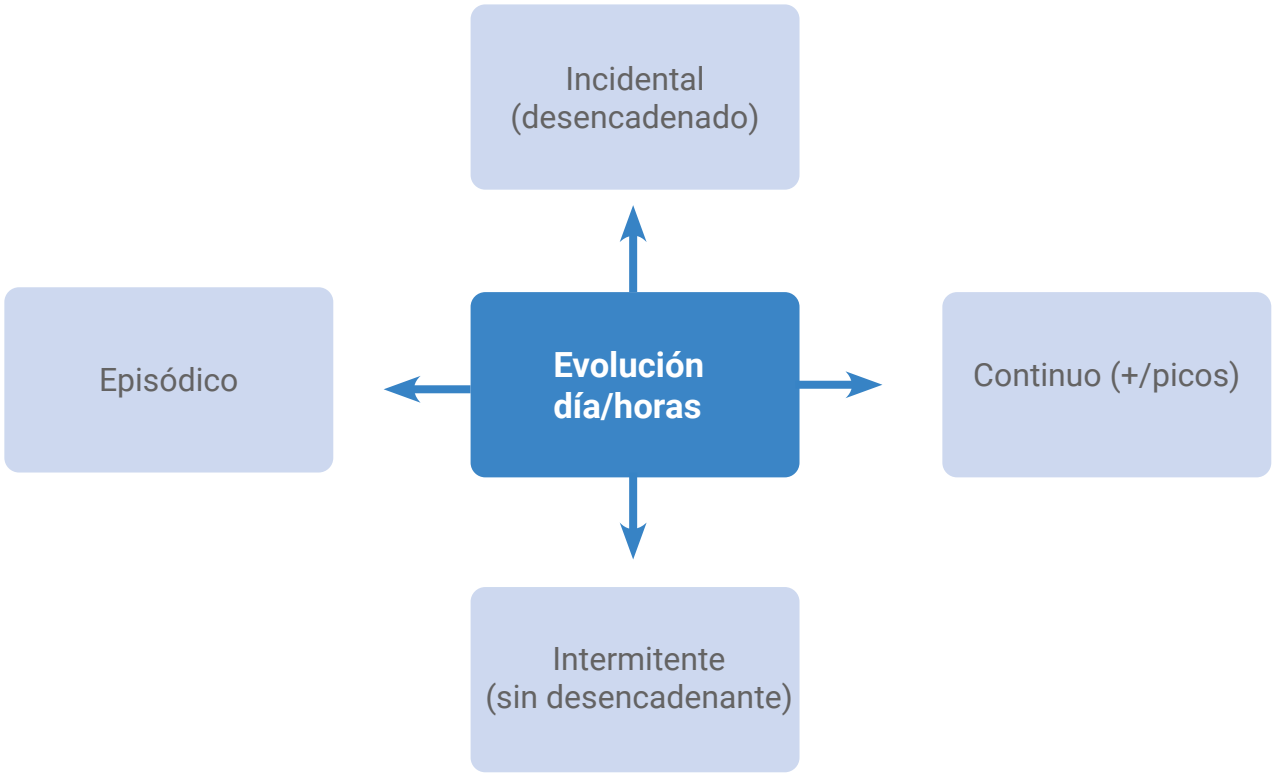

Figura 5.

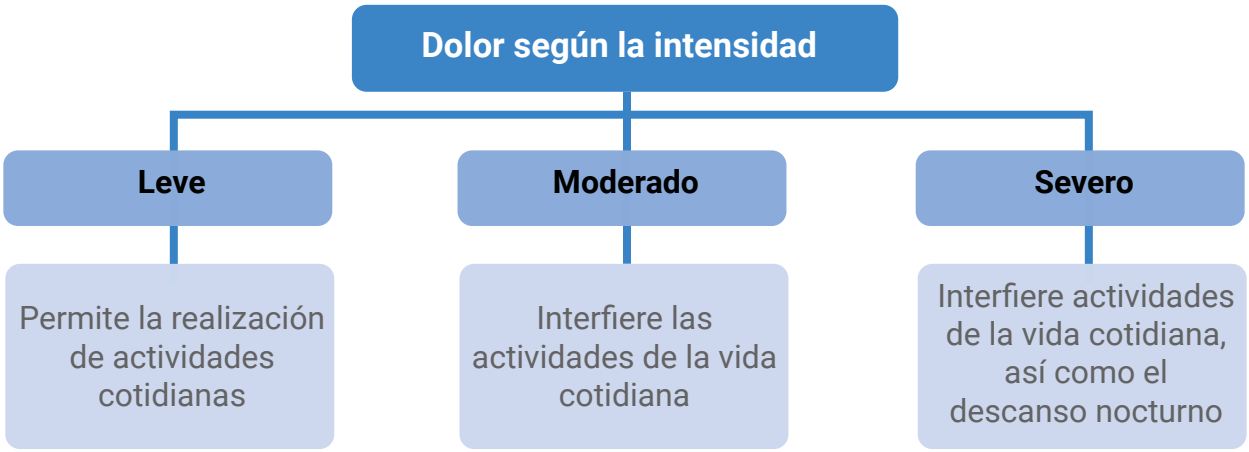

Figura 6.

Clasificación fisiopatológica del dolor crónico		
Nociceptivo	**Neuropático**	**Psicógeno**
Somático: generalmente percibido como irruptivo y punzante, bien localizado, clara relación con vías nociceptivas, buena respuesta a AINE y tumores óseos u osteotendinosos.	Secundario a lesión/ disfunción en estructuras neurológicas, origen central o periférico, persístete + exacerbaciones, Alodinia e hiperalgesia, asociado a alteraciones tróficas, síndrome post amputación y parálisis cerebral.	No congruente con patología orgánica de base, múltiples factores psicosociales en el entorno del paciente (malos tratos, abandono o pérdida de familiar) demanda continua de tratamiento sin efectividad y trastornos psíquicos asociados.
Visceral: peor localización, irradiado a zonas lejanas al origen, cortejo vegetativo, buena respuesta a opioides, tumores viscerales primarios o metastásicos y dolor abdominal crónico.		

Tabla 6.

Esto obliga a basarse en evidencias fisiológicas y alteraciones conductuales que deben ser interpretadas por personal entrenado en la valoración del dolor en el paciente pediátrico, o bien, basarse en las observaciones del cuidador principal del niño, en muchas ocasiones los padres, cuyo componente emocional y de responsabilidad genera casi siempre que se distorsione la información que el evaluador obtiene (10) *(figura 7).*

Figura 7.

Las condiciones básicas de la entrevista clínica deben ser respetadas de forma más marcada en el paciente pediátrico, que no confiará en el personal sanitario y que en muchas ocasiones los habrá relacionado con prácticas dolorosas o traumáticas, lo que genera una falta de comunicación o imposibilidad para evaluar al paciente infantil. En el caso de los niños cobra más sentido el empleo de la entrevista semiestructurada en la que participará el paciente en el grado que sea posible, adecuado a la edad y el cuidador principal de este.

Los objetivos de la entrevista clínica son comunes en los niños y en los adultos. La entrevista médica es muy importante para la realización de una evaluación psico-social, esta permitirá obtener información acerca de la personalidad del paciente y la presencia de síntomas de alteración psicológica como ansiedad, depresión, angustia, entre otras (10,11) *(tabla 7).*

Objetivos de la entrevista clínica
Establecer una relación médico-paciente adecuada.
Detectar factores psicológicos coadyuvantes.
Obtener información necesaria para poder clasificar el dolor que sufre el paciente.
Determinar un enfoque diagnóstico.
Planificar el abordaje terapéutico.
Determinar aspectos socioambientales que influyen en el dolor.
Determinar factores físicos o psíquicos de alarma.

Tabla 7.

Así como detectar la existencia de desórdenes mentales de mayor rango, existen también cuestionarios encaminados a valorar aspectos afectivos del dolor como el cuestionario sobre Ansiedad Estado-Rasgo de Spilberger (STAI) o la escala de Depresión de Beck (BDI).

En los últimos años se viene utilizando, por la facilidad de aplicación y fiabilidad, la escala de Ansiedad-Depresión Hospitalaria (HAD), otro de los más usados es el MMPI (*Minessota Multiphasic Personality Inventory*), se trata de un inventario de personalidad que permite el establecimiento de perfiles de personalidad útiles para descartar la presencia, o no, de psicopatología en el sujeto, aunque es un instrumento ampliamente utilizado, está siendo criticado, dado que la presencia de rasgos psicopatológicos no implica necesariamente el origen psicógeno del dolor crónico.

En esta fase se deben explorar también otros aspectos relevantes, que pueden modular la respuesta al tratamiento, como la existencia de litigio (bajas laborales o escolar o sentencias de incapacidad), problemas económicos o de problemática social, así como las expectativas del paciente respecto a la terapia (10,11) *(tabla 8).*

Para la realización de una entrevista médica al paciente en edades pediátrica se deben tener presentes varios aspectos, tales como:

- La entrevista clínica del paciente pediátrico conlleva a la realización de una exploración física completa y exhaustiva de la que se obtendrá información complementaria muy útil para completar la dificultad de comunicaciones con el paciente. No obstante, hay que estar muy entrenado en la realización de la exploración física, ya que la falta de colaboración puede hacer imposible la obtención de datos válidos o la realización de maniobras exploratorias. Es necesario contar con el consentimiento y la colaboración del paciente en todo momento y evitar la realización de pruebas desagradables o dolorosas en pacientes que no puedan comprender el objetivo beneficioso de la actuación del clínico (10,11).

En resumen, la entrevista tiene como primer objetivo ganarse la confianza del paciente transmitiéndole credibilidad en el padecimiento. Suelen ser enfermos con fracasos terapéuticos que han recibido incomprensión y rechazo, tanto de médicos como del entorno familiar y social. El convencimiento de que el padecimiento no es tan raro y de que el médico tiene cualificación especial para tratar el problema y va a poder ayudarle, crea una luz de esperanza que es muy beneficiosa para conseguir la colaboración y elevar el optimismo a la vez que mejoran los resultados. Esto se consigue transmitiendo humanidad y consideración en un entorno tranquilo y durante el tiempo necesario. La discusión del dolor con el paciente puede hacer aflorar signos psicológicos clave en el diagnóstico. El siguiente objetivo es elaborar un plan de evaluación y un tratamiento que sean aceptados por el paciente.

Evaluación del dolor crónico en el paciente pediátrico

Evaluar el dolor tiene la finalidad de objetivar el nivel de percepción dolorosa subjetiva que sufre el paciente para poder estratificar el plan terapéutico proporcional a cada caso. Es una tarea ardua dado el alto nivel de subjetividad que plantea el dolor crónico, lo cual es más complejo en el paciente pediátrico. Por ese motivo se aplican en la práctica clínica diferentes modelos de objetivación del dolor.

El objetivo fundamental de los diferentes tipos de medición es adecuarse a la población pediátrica, con una gran variabilidad. El abordaje del paciente preescolar es totalmente diferente del abordaje en paciente mayor de 6 años, del preadolescente o adolescente. En estas edades, el grado de madurez se relaciona poco con la edad del paciente y será en la entrevista clínica el momento en el que el clínico determinará la forma de evaluar el dolor en cada caso (11).

En general, las herramientas para evaluar el dolor en pacientes pediátricos no se han validado para todas las edades, pero aquellas que pretendan gradar la sensación dolorosa que padece un niño debe seguir las reglas de la herramienta QUESTT. En el caso de pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, se han propuesto enfoques como el del programa marco ADOPT. Basados en estas aproximaciones, el esquema de atención sistemática del niño con dolor crónico podría seguir las iniciales "PERCIBE", que se resume en los siguientes pasos (11,12):

- **P – Percepción:** preguntar al niño/cuidador principal si existe dolor y si reúne las características de dolor crónico.
- **E – Evaluación del dolor:** usando la escala más apropiada. Si es posible, el niño podría elegir la que más le atraiga.
- **R – Reconocimiento:** se debe asegurar que el paciente no presenta un proceso agudo y potencialmente tratable que haya aumentado la intensidad/sensación del dolor.
- **C – Condicionantes:** se deberán tener en cuenta alteraciones fisiológicas (incluyendo aumento o pérdida de peso), comorbilidades de base o alteraciones de comportamiento que influyan en una reagudización o aumento del dolor.
- **I – Iatrogenia:** repasar la medicación que recibe el paciente, los posibles efectos secundarios o la necesidad de modificación de la misma (dosis, especialidad farmacéutica, formulación, entre otras).
- **B – Base de apoyo:** asegurarse de qué paciente y cuidadores disponen de un apoyo social suficiente y anticipar ciclos vitales (escolarización, adolescencia y enfermedad de convivientes).

Entrevista clínica en el paciente pediátrico
Primer paso esencial: establecer una relación de confianza con el paciente y los acompañantes.
Detectar y combatir conductas emocionales asociadas tanto de los pacientes como de los acompañantes (frustración, miedo, depresión o desconfianza).
Establecer un ambiente tranquilo y sin interrupciones.
Evitar exploraciones incómodas o molestas para el niño en la medida de lo posible.
Evitar que la consulta sea un ambiente hostil para el niño y potenciar la sensación de seguridad.
El paciente debe estar acompañado por las personas de confianza a lo largo de la entrevista clínica.
Se permitirá que el paciente participe y tome decisiones acerca del proceso, en la medida del grado de madurez y valorándolo de forma individualizada.

Tabla 8.

- **E- Establecimiento:** de un plan de tratamiento y evaluación de resultados (analgesia, medidas físicas, psicológicas, entre otras).

Las escalas a utilizar y los cuestionarios son ideales para la evaluación del DC en edades pediátricas. Estos se caracterizan por ser sencillos, fácilmente comprensible, reproductibles, fiables y válidos en términos clínicos. Existen multitud de modelos de evaluación, numéricas, gráficas, descriptivas y conceptuales con las que se tratan de alcanzar los estándares ideales, pero todas ellas cuentan con ventajas y desventajas que se deberán tener en cuenta a la hora del empleo en la práctica clínica.

Yaffa Zisk – Rony R. et al, publican en el año 2015 los resultados de un estudio descriptivo transversal unicéntrico, donde se determina como principal forma de valorar el dolor del paciente pediátrico, por parte de profesionales sanitarios responsables, la observación e impresiones de enfermeras, además de escalas de tipo numéricas. En ese mismo año, Shomaker K. et al, publicaron un estudio descriptivo transversal en el que destacan como métodos de valoración del dolor, la escala FLACC (*Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability*), la escala NIPS (*Neonatal Infant Pain Scale*) y escalas numéricas (11-14).

Indudablemente, la utilización de las diferentes escalas y cuestionarios para evaluar el dolor son muy importantes y necesarios. Entre las fundamentales con las que se cuentan en la práctica clínica diaria *(figura 8).*

Escalas verbales unidimensionales

- **Escala Visual Analógica (EVA):** fue ideada por Aitken y consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones del dolor como síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad del dolor y en el derecho la mayor intensidad.

  Se le pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada, esta intensidad se expresa en centímetros o milímetros. Si el paciente puntúa el dolor por debajo de 3cm se registra dolor leve, será dolor moderado si se puntúa entre 4 y 7cm y severo cuando la puntuación sea igual o superior a 8cm. Este tipo de escala es comprendida y puede ser utilizada a partir de los seis años de edad aproximadamente (15,16).
- **Escala facial de Wong-Baker:** se trata de una escala que representa seis rostros que expresan desde felicidad (rostro 0) a máxima tristeza (rostro 5). Estas imágenes corresponderán con el registro de diferentes intensidades de dolor, donde el rostro 0 es no duele y el rostro 5 es dolor de intensidad máxima, pasando por “duele muy poco”, “dolor perceptible” y “dolor intenso”.

  Se trata de una escala que se puede utilizar desde los 3 años de edad, por lo que se emplea habitualmente para los pacientes en edad pediátrica (15,16) *(figura 9).*

Figura 8.

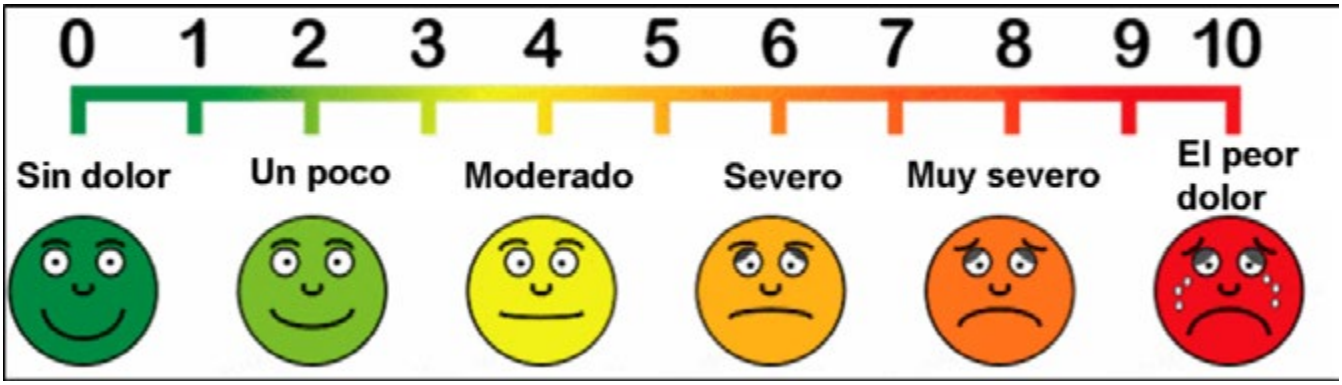

Figura 9.

Escalas verbales multidimensionales

Tienen la ventaja de ser más completas a la hora de aportar información, puesto que asumen la multidimensionalidad del dolor y evalúan el componente sensorial, afectivo y evolutivo del dolor. Este tipo de escalas son más efectivas para la valoración del dolor crónico (15,16).

- **McGill Pain Questionnaire (MPQ):** el cuestionario presenta varias partes bien diferenciadas, localización, cualidad, intensidad y valoración del dolor en el momento actual. El paciente irá escogiendo los adjetivos de cada una de las subcategorías, todos ellos corresponden con un valor numérico. Este cuestionario presenta ciertas limitaciones, algunos pacientes tienen dificultades para la comprensión, en ocasiones, resulta ambiguo y la variabilidad del número y rango de los ítems genera dudas acerca de la validez del resultado de la puntuación (15,16) *(tabla 9).*
- **Cuestionario del Dolor en Español (CDE):** se trata de un cuestionario con grandes similitudes con el McGill Pain Questionnaire que, además, añade una Escala Visual Analógica (EVA) y la representación de una figura humana para facilitar la localización del dolor, lo que promueve la comprensión por pacientes jóvenes (15,16).
- **Cuestionario breve del dolor (BPI):** se trata de un cuestionario que se diseñó en un principio para pacientes con dolor oncológico, pero su uso se ha extendido a otros tipos de dolor. Incluye cuestiones que permiten valorar la respuesta al tratamiento y determinar la causa y la localización del dolor (15,16).

Escalas conductuales

- **Escala de CHEOPS:** indicada en aquellos casos en los que es imposible la comunicación oral, como los menores de 3-4 años. Es una escala validada que se considera gold estándar en pacientes pediátricos preescolares y que valora seis parámetros, el llanto/grito, expresión del rostro, verbalización, actitud corporal, deseo de tocar la herida y la posición de los miembros inferiores. Existen otras escalas validadas como la escala del llanto (15,16).
- **Escala de Campbell:** se trata de una escala no validada que se basa en cinco parámetros, tales como la musculatura facial, tranquilidad, tono muscular y confortabilidad. Podría tener aplicación cuando el paciente no tiene capacidad de comunicación; no obstante, es poco utilizada, principalmente, porque no ha sido aún validada (15,16).

Las escalas a utilizar y los cuestionarios para la evaluación del dolor crónico en edades pediátricas
Escalas verbales unidimensionales
Escala facial de Wong-Baker
Escala Visual Analógica (EVA)
Escalas verbales multidimensionales
McGill Pain Questionnaire (MPQ)
Cuestionario del Dolor en español (CDE)
Cuestionario breve del dolor (BPI)
Escalas conductuales
Escala de CHEOPS
Escala de Campbell
Escala de Susan Givens Bell
Métodos de evaluación para adultos
West Haven-Yale Multidimensional Inventory (WHYMPI)
Cuestionario de afrontamiento del dolor crónico
Pruebas de evaluación aspectos psicológicos y psicopatológicos de la personalidad
Cuestionario de personalidad de Eynsenck Revisado (EPQ-R)
Listado de Síntomas Breve (LSB-50)

Tabla 9.

- **Escala sobre conductas indicadoras de dolor:** se basa en la escala de Campbell y añade la adaptabilidad a la ventilación mecánica. Desarrollada para la valoración del dolor de pacientes en unidades de cuidados críticos, pero aún requiere validación (15,16).
- **Escala de Susan Givens Bell:** aúna signos conductuales como el llanto y el rechazo, con valores fisiológicos desencadenados por el dolor como la frecuencia cardiaca o respiratoria (15,16).

Cuando el paciente es algo mayor y el grado de madurez lo permite, se pueden emplear métodos de evaluación utilizadas en adultos que engloban los aspectos emocionales y psicológicos del dolor. Los más destacables son:

- **West Haven-Yale Multidimensional Inventory (WHYMPI):** es un cuestionario ampliamente aceptado en la actualidad, una de sus ventajas es que aborda la evaluación del dolor desde una base teórica cognitivo-conductual. Se trata de un cuestionario de fácil respuesta por parte del paciente y que se adapta a múltiples niveles socioculturales (15,16).
- **Cuestionario de afrontamiento del dolor crónico:** inicialmente incluye 31 ítems y recoge seis factores: autoafirmación, búsqueda de información, religión, distracción, catarsis y autocontrol mental. Su versión reducida, con 24 ítems, incluye la evaluación del concepto de afrontamiento del dolor crónico, este aspecto es relevante, ya que las conductas de afrontamiento actúan como moduladoras del componente emocional del dolor y pueden favorecer la adaptación o desadaptación del paciente a su situación clínica (15,16).

Pruebas dirigidas a conocer aspectos psicológicos y psicopatológicos de la personalidad de los pacientes:

- **Cuestionario de personalidad de Eynsenck Revisado (EPQ-R):** evalúa las tres dimensiones básicas de la personalidad (extraversión, neuroticismo y psicoticismo), junto con una escala complementaria de disimulo que permite medir la deseabilidad social (12,15-17).
- **Listado de Síntomas Breve (LSB-50):** consta de 50 ítems y está compuesto por siete escalas principales (psicorreactividad, hipersensibilidad, obsesión compulsión, ansiedad, hostilidad, somatización y depresión), dos subescalas (alteraciones del sueño y alteraciones del sueño ampliadas) y una escala de riesgo psicopatológico (12,15-17).

En la evaluación de los pacientes con dolor, también se pueden obtener de forma complementaria, otras mediciones a través de pruebas psicológicas objetivas dirigidas a recoger información sobre los aspectos de la personalidad, los estados afectivos, los posibles rasgos o tendencias psicopatológicas de los pacientes. Entre las cuales, se pueden destacar (12,16,17):

- ***Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI):** evalúa la personalidad y rasgos psicopatológicos.
- ***Symptom Checklist-90* (SCL-90):** evalúa los síntomas de malestar físico o emocional en una lista de 90 problemas.
- ***Millon Behavioral Health Inventory* (MBHI):** evalúa los tipos de personalidad y las actitudes relevantes para dolencias específicas, además, contiene un índice pronóstico que intenta predecir la respuesta al tratamiento del dolor.

En resumen, el dolor crónico en el paciente pediátrico se visualiza, aunque no con mucha frecuencia se puede ver en ocasiones. Es importante en estos casos conocer las herramientas que se tienen al alcance para evaluar e identificar los factores que agravan el dolor crónico en el paciente pediátrico. Se hace necesario señalar, además, que en muchos de estos pacientes se pueden utilizar escalas y cuestionarios para determinar otros trastornos asociado al dolor crónico.

Bibliografía

1. Force APSPCPT (American Pain Society: Pediatric Chronic PainTask Force). Assessment and management of children with chronic pain. A position statement from the American Pain Society. 2012. Availableat: http://americanpainsociety.org/uploads/get-involved/pediatric-chronic-painstatement.pdf.AccessedSeptember3,2019
2. Gloria Guerrero Márquez, M.ª Concepción Miguez Navarro, Isabel Sánchez García, Mariano Plana Fernández, María Ramón Llácer. Manejo del dolor en urgencias pediátricas. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), 3ª Edición, 2019.
3. Bilbenyab N. Chronic pain in Chile. Revista médica clínica los Condes [Internet]. 2019; 30(6):397 https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.08.002.
4. Portenoy R, Dhingra L. Assessment of cancer pain. Uptodate [Internet]. 2020; 3. Available at: https://www.uptodate.com/contents/assessmentof-cancer-pain.
5. García J. Manejo básico del dolor agudo y crónico. Anestesia en México [Internet]. 2017; 29(1):80. Available at: http://www.scielo.org.mx/pdf/am/v29s1/24488771-am-29-00077.pdf.
6. Margarit C. La nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y el dolor crónico. Implicaciones prácticas. Rev. Soc. Esp. Dolor 2019; 26(4): 209-210 https://doi.org/10.20986/resed.2019.3752/2019.
7. Nicholas, M., Vlaeyen, J., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Benoliel, R Treede, R. (2019). The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain 160(1): 28-37. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001390.
8. José Eduardo Bendaña. Dolor neuropático: actualización en definiciones y su tratamiento farmacológico. Rev. Méd. Hondur., Vol. 88, Núm. 1, 2020.
9. Bouhassira D. Neuropathic pain: definition, assessment and epidemiology. Rev. Neurol (Paris). 2019; 175(1-2):16-25.
10. Erick Gerardo Blanco Naranjo, Gary Felipe Chavarría Campos, Yorlin María Garita. Fallas Manejo multimodal del dolor crónico. Revista Médica Sinergia. Vol. 6(4), abril 2021 - ISSN:2215-4523 / e-ISSN:2215-5279.

11. M. T. Vicente Herrero, S. Delgado Bueno, F. Bandrés Moyá M. V. Ramírez Iñiguez de la Torre y L. Capdevila García. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev. Soc. Esp. Dolor 2018; 25(4): 228-236. DOI: 10.20986/resed.2018.3632/2017.

12. Justicia Grande J.A, Abreu García T. Dolor Crónico en pacientes con alteraciones neurocognitivas. Grupo de trabajo para abordaje del dolor pediátrico en la Atención Primaria (SEPEAP). 2018.

13. Zisk – Rony RY, Lev J, Haviv H. Nurse's Report of in-hospital pediatric pain assessment: examining challenges and perspectives. Pain Manag Nurs 2015;16(2):112-20.

14. Shomaker K, Dutton S, Mark M. Pain prevalence and treatment patterns in a US children's hospital. Hospital Pediatrics 2015;5(7): 363-70.

15. Gaglani A, Gross T. Pediatric Pain Management. Emerg MedClin North Am. 2018; 36:323-34, http://dx.doi.org/10.1016/j.emc.2017.12.002 [Review].

16. Vicente Herrero MT, Delgado Bueno S, Bandrés Moyá F, Ramírez Iñiguez de la Torre MV y Capdevila García L. Valoración del dolor. revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev. Soc. Esp. Dolor 2018;25(4):228-236.

17. Miró J, de la Vega R, Solé E, Castarlenas E, Sánchez Rodríguez E, Galán S y Roy R. Psicología y dolor crónico infantil. Rev. Soc. Esp. Dolor 2018;25(Supl.1):46-56.